语言沟通联合心理护理对抑郁症患者的干预效果研究

刘树梅　张笑颜

黄骅安定医院　河北　黄骅　061100

【摘要】**目的：**探讨抑郁症患者在接受心理护理与语言沟通护理后对于减轻其自身抑郁情绪、提高自我接纳度所发挥的作用。**方法：**护理对象是 72 例患有抑郁症的患者，设置成两个对照小组后实施不同护理形式并形成对比，比较护理后抑郁情绪评分、生活质量评分及自我接纳度评分。**结果：**实施联合护理方式组所取得的指标评分明显优于单一护理形式组，组间数据对比存在差异性。**结论：**在抑郁症患者的护理中，语言沟通与心理护理均是非常重要的，联合实施所取得的护理价值更高，建议推广。

【关键词】抑郁症；语言沟通；心理护理

随着生活压力的增加，社会生存节奏的加快，抑郁症患者的数量呈现逐年上升的趋势 [1]。这是一种较为多见的精神障碍疾病，典型症状是兴趣减退、情绪低落、思维迟缓等，症状加重时会导致患者出现认知功能障碍，甚至出现自伤、自杀等想法（行为）。抑郁症患者的自我接纳程度较低，甚至难以适应社会生活 [2]。当前针对抑郁症的治疗方式是口服抗抑郁药物，但此类药物的长期应用伴随着一些副作用，且依赖性明显，部分患者无法坚持配合治疗 [3]。临床护理研究发现，抑郁症患者在治疗中不仅要规范用药，还需要加强沟通，增加患者对自身疾病的认知，提高配合程度。语言沟通是通过各种语言沟通技巧对患者进行护理的方式，可以真实获取患者内心心理状态，用语言交流的方式拉近护患距离，从而改善患者的情绪状态 [4]。心理护理是利用专业的心理学知识对患者开展的护理，可以直接影响患者的心理活动，从而达到纠正不良认知、减少抑郁情绪的护理目标 [5]。在本次的课题分析研究中，将心理护理与语言沟通联合开展在抑郁症患者的护理中，探索其价值。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择研究时间是 2021 年 4 月—2022 年 4 月，所护理的对象是 72 例患有抑郁症的患者。在护理研究中，按照电脑随机分组的方式将患者划分至两组，并实施不同的护理模式，观察组联合应用两种护理模式，对照组则实施常规护理。纳入标准：符合临床上对抑郁症的确诊标准，患者具有一定沟通能力与认知能力；同意参与本次研究；无家族遗传精神病史。排除标准：其他类型精神疾病；意识障碍，无法与人沟通；器官器质性功能障碍；肿瘤疾病等。统计两组患者的数据资料时，对比组间的年龄、性别与病程数据，发现无差异性对比，$P>0.05$，见表 1.

表 1　患者资料数据统计（n,$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	男性（例）	女性（例）	年龄范围（岁）	平均年龄（岁）	病程（年）	平均病程（年）
观察组	36	15	21	22-64	43.12±0.37	0.7-5.2	3.17±0.37
对照组	36	16	20	23-66	42.91±0.12	0.6-5.5	3.03±0.14
x^2/t 值	-	0.05	0.05		3.23	-	2.12
P 值	-	0.81	0.81	-	0.00	-	0.03

1.2 护理方法

1.2.1 对照组

向患者实施常规性的护理内容，护理人员要向患者讲解按时服药的重要性，叮嘱患者不要擅自停药。向患者讲解日常饮食的注意实现，鼓励患者多晒太阳，不要接触容易引起自己焦虑的事物。

1.2.2 观察组

所实施的护理方法是心理护理与语言沟通相结合的护理模式。①心理护理。抑郁症患者往往对治疗伴随着抵触心理或是存在恐惧感。护理人员要主动与患者交流，善用心理护理的技巧来减轻患者的恐惧情绪 [6]。面对患者及家属的提问或疑虑，要耐心进行解答，同时做好抑郁症疾病知识的科普宣传，消除误解。告知患者各项治疗与护理都是隐秘的，并不会被其他人所知晓，进而让患者有安全感 [7]。在护理期间，可以让患者聆听一些舒缓的音乐，如《渔樵唱晚》《马兰开花》等，此类音乐可以帮助降低患者大脑的兴奋性，从而缓解抑郁情绪。②语言沟通，利用语言沟通、问题重构等技能对患者的倾诉进行肯定，与患者进行良好的沟通。护理人员需要让患者感受到护理人员的亲

切感与认同感，可以感受自己当前的痛苦。可以搭配适当加上动作给予鼓励和支持，使患者主观愿意继续交流 [8]。与患者进行交谈的过程中，护理人员必须接纳患者的情绪和聊天内容，不得怀疑或反问，避免增加患者的内心负担。当患者在沟通过程中无法完整表达自己的情感时，护理人员要鼓励患者对自己内心的真实想法进行表达。利用肢体语言表达对患者的了解和认同，比如可以在交流过程中轻拍患者的肩膀或者帮助患者整理头发、衣服等让患者感受到更多的温暖，促进护理工作的顺利完成。沟通中可习惯性使用“我们”一词，以增加患者归属感，建立良好的沟通关系 [9]。与患者聊家属和家庭情况，了解患者的家庭地位和社会职能，若患者与家庭和睦，可利用亲情疏导患者的负面情绪，并引导家属多关怀、陪同患者。若患者与家庭关系并不算和睦，可适当避开家庭话题，引导其多讲一些社会贡献等，提升其成就感，让患者愈加期待回归社会 [10]。

1.3 评价指标

在两组内护理措施实施完毕后，需要对两组患者所取得的护理效果。

（1）抑郁情绪指标。选用 HAMD 汉密尔顿抑郁情绪评估量表对两组患者所表现出的抑郁情绪进行评估，量表内共含有 17 项评价的内容，包含疑病、胃肠道症状、自知力等，在评估后计算总分，若分值超过 8 分可以考虑患者存在抑郁情绪，若分值超过 21 分可认定患者存在抑郁症分值在 35 分代表严重抑郁症 [11]。

（2）自我接纳评分。自制抑郁症患者自我接纳调查问卷发放给患者，向患者讲解问卷内所含有的内容并叮嘱患者独立、真实完成，并签署问卷保密协议。问卷内共计含有 16 个项目，总分是 80 分。问卷计算总分值越高，

（3）生活质量。评估两组护理后的生活治疗，选用 GQOLI-74 评分量表，量表从患者的社会功能、躯体功能、心理功能与物质生活四个方向进行评估，总分值是 100 分，评分越高代表患者当前的生活质量更好。

1.4 统计学方法

分析指标数据，运用 SPSS25.0 的软件处理功能，对组间数据进行记录与对比，以率或（$\bar{x}\pm s$）作为数据的表示形式，检验时相应的方法是 x^2 或 t。在分析数据后，判定组间数据存在差异性的唯一前提是 $P<0.05$。

2 结果

2.1 抑郁情绪

患者的抑郁情绪评价可以直接评估病情的变化，在表 2 内的数据统计中，护理后观察组患者的抑郁情绪评分更低，相较于对照组形成对比。

表 2 评估患者的抑郁情绪数据统计（分，$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	护理前	护理后
观察组	36	17.51±1.32	7.15±0.15
对照组	36	17.52±1.16	13.96±0.47
t 值	-	0.03	82.82
P 值	-	0.97	0.00

2.2 自我接纳度

患者的自我接纳度越高，代表病情越轻，恢复效果更好。从表 3 内的数据记录上看，观察组患者在护理前的自我接纳度评分较低，组间数据对比无差异性；护理后，观察组患者的自我接纳度明显提升，评分高于对照组，$P<0.05$。

表 3 患者自我接纳度评分数据统计（分，$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	护理前	护理后
观察组	36	35.16±1.36	59.51±0.19
对照组	36	35.72±1.17	48.62±0.33
t 值	-	1.87	171.59
P 值	-	0.06	0.00

2.3 生活质量

护理有助于改善患者的生活质量，观察组患者的评分更高，体现在表 4 内的数据统计中。

表 4 两组患者生活质量数据评分（分，$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	社会功能	躯体功能	心理功能	物质生活
观察组	36	86.15±0.14	88.61±0.18	89.61±0.14	87.16±0.52
对照组	36	70.69±0.27	72.64±0.36	75.69±0.32	76.59±0.13
t 值	-	304.99	238.06	239.11	118.32
P 值	-	0.000	0.000	0.000	0.000

3 讨论

3.1 抑郁症简述

抑郁症的发病率渐有逐年提升的趋势，患者年龄年轻化，疾病给患者造成极大的痛苦，自我价值感认同低，容易出现自杀、自伤等行为。关于抑郁症的发病原因，临床普遍性认为遗传、神经内分泌、心理社会因素等综合性因素相关。抑郁症的治疗需要患者规范用药，通过坚持服药有助于控制患者病情的进展，减轻抑郁情绪 [12]。但是在服药过程中伴随着较多的副作用，患者会出现呕吐、头痛等症状，因此会出现不

配合治疗的情况。由此可见，抑郁症的治疗不仅要进行药物控制，还需要提供有效的护理干预，增加患者对自身疾病的认知，降低复发几率。抑郁症患者不愿与人沟通，内心较为封闭，常规护理在开展时会面临阻碍。加之常规性护理内容侧重于药物、饮食及日常生活方面的指导，缺少对患者内心的护理，因此抑郁症患者的内心情绪未得到重视，病情恢复效果较差[13]。

3.2 研究护理价值

本次课题分析中提出的护理方法是语言沟通和心理护理联合实施。护理人员要主动与患者交流，通过沟通中把握患者的情绪状态，了解患者的情绪状态与护理需求，从而为患者制定科学的护理方法[14]。在语言沟通过程中善用心理护理技巧，提高患者面对疾病治疗的信心，主动配合，自觉对抗消极情绪[15]。联合护理在实施时消除护患之间的界限隔阂，鼓励患者倾诉自己的内心感受，敞开心扉，表达自己的感受，从而减轻抑郁情绪。

3.3 数据分析

观察组所接受的护理方法是联合护理，对照组仅实施常规护理的内容，从患者的抑郁情绪、自我接纳度与生活质量三项评分指标来评估护理的效果。表 2 记录患者的抑郁情绪，观察组患者的抑郁情绪从护理前的（17.51±0.32）分降低至护理后的（7.15±0.15）分，对照组患者的抑郁情绪评分从护理前的（18.52±0.16）分降低至（13.96±0.47）分，护理后两组患者的抑郁情绪得到显著好转，但观察组评分降低更显著，表示联合护理有助于减轻抑郁症患者的抑郁情绪，促进疾病好转。表 3 记录患者的自我接纳度评分。抑郁症患者的自我价值感认同低，也因此会产生情绪低落，甚至是自伤行为。护理措施的实施帮助患者发现自我价值，对自我的接纳度更高。观察组患者护理后的自我接纳度评分是（59.51±0.19）分，对照组患者的评分是（48.62±0.33）分，观察组患者的自我接纳度更高。表 4 记录患者的生活质量，观察组患者在评估后的分值更高，进一步体现出语言沟通与心理护理所发挥的作用。

综上，在抑郁症患者的护理中，建议将语言沟通与心理护理联合实施，构建和谐的护患关系，提高患者的自我接纳度，减轻患者的抑郁情绪，是一种能够改善患者生活质量的有效护理方法，值得认可与推广。

参考文献

[1] 费嘉，赵金燕，王菁. 综合心理护理在精神分裂症患者中的应用价值分析 [J]. 心理月刊 ,2023,18(13):82-84.

[2] 任秀，王艳，张静. 共情护理在抑郁症患者中的应用有效性 [J]. 心理月刊 ,2023,18(13):109-111.

[3] 李露露，杨玉琳，江琴. 综合性心理护理对抑郁症患者的影响 [J]. 心理月刊 ,2023,18(11):143-145.

[4] 王洁. 基于语言沟通的心理护理模式用于精神病患者护理中的效果 [J]. 心理月刊 ,2023,18(10):144-146.

[5] 张红，张益磊，宋健美等. 人际心理治疗在精神病住院患者中的应用效果 [J]. 心理月刊 ,2023,18(6):173-175.

[6] 张兆英. 个性化护理对抑郁症患者生活质量的影响研究 [J]. 中国城乡企业卫生 ,2023,38(3):7-9.

[7] 于东玲，董晓芳，李言波. 健康教育及心理护理对抑郁症患者的影响研究 [J]. 心理月刊 ,2023,18(4):140-142.

[8] 翁春霞. 心理护理改善抑郁症患者睡眠质量和临床症状的效果观察 [J]. 世界睡眠医学杂志 ,2023,10(2):333-335.

[9] 桑艳云，许兵，吉明明. 心理护理对抑郁症患者的影响 [J]. 心理月刊 ,2023,18(2):118-120.

[10] 刘云侠，祝玉玲，赵玉灿. 精神病患者应用心理护理和语言沟通的临床效果观察 [J]. 心理月刊 ,2023,18(2):167-169+172.

[11] 黄满娥，李星逸，王贻进. 语言沟通联合心理护理对抑郁症患者的干预效果研究 [J]. 心理月刊 ,2022,17(9):38-40+73.

[12] 朱丹丹，魏帮云，莫丽. 住院老年精神病患者的心理护理效果分析 [J]. 心理月刊 ,2022,17(9):211-213.

[13] 李晓瑜. 综合护理对抑郁症患者抑郁情绪以及生活质量的影响研究 [J]. 中国医药指南 ,2022,20(3):11-14.

[14] 曲立新，黄传浩. 知信行模式下的心理护理对抑郁症患者的护理效果 [J]. 中国医药指南 ,2021,19(14):140-141.

[15] 田宁. 心理护理合并护患沟通技能在抑郁症患者中的应用及对患者依从性、焦虑抑郁评分改善情况的影响 [J]. 中国医药科学 ,2021,11(9):133-136.

作者简介：刘树梅(1978-)，女，大专，主管护师，E-mail：36973290@qq.com